

Zdrowie *fizyczne* ma znaczenie

Osoby z psychozą żyją 15–20 lat krócej — głównie z powodu chorób serca, nie samobójstw. Ruch, dieta, palenie, sen — krytyczne. Każda wizyta psychiatryczna powinna obejmować zdrowie fizyczne.

CZAS: 15 min · do regularnego przeglądu Każdy pacjent na antypsychotyku

ŹRÓDŁO: Hjorthøj i in. (2017); Firth i in. (2015); Lawrence i in. (2013); NICE (2014)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum, **dłaczego zdrowie fizyczne jest priorytetem** w psychozie (sekcja 1), zaplanuj **regularny monitoring metaboliczny** (sekcja 2) i wybierz **trzy konkretne zmiany** na ten miesiąc (sekcja 4). Sekcja 3 — sześć obszarów do zaopiekowania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hjorthøj i in. (2017, badanie populacyjne na 250 000 osób): **osoby z psychozą żyją 15–20 lat krócej** niż populacja ogólna. *Główna przyczyna:* choroby sercowo-naczyniowe (zawały, udary), **nie** samobójstwa. Przyczyny: antypsychotyki (przyrost masy, cukrzyca, dyslipidemia), sedentarny styl życia, palenie (70% pacjentów pali), ubóstwo, gorszy dostęp do opieki somatycznej. Firth i in. (2015, meta-analiza 17 RCT): **ćwiczenia aerobowe poprawiają nie tylko zdrowie fizyczne, ale także objawy negatywne, funkcje poznawcze i depresję** u osób z psychozą. To rzadkie połączenie — interwencja, która działa na wielu poziomach jednocześnie.

01 = Skala problemu

15–20 LAT

krócej życia niż populacja ogólna (Hjorthøj 2017). Skandal zdrowia publicznego, który rzadko trafia do mediów.

2× WYŻSZA

śmiertelność z powodu chorób serca (Lawrence 2013). Choroby sercowo-naczyniowe są **główną** przyczyną przedwczesnej śmierci.

70% PALI

papierosy (vs ~20% w populacji ogólnej). Palenie to **najważniejsza modyfikowalna** przyczyna przedwczesnej śmierci.

Dobra wiadomość: wszystkie główne przyczyny są *modyfikowalne*. Ruch, dieta, rzucanie palenia, *monitoring* metaboliczny — działania, które realnie wydłużają życie. Firth (2015): nawet umiarkowana aktywność (3×/tydz. po 30 min) ma znaczący efekt.

02 ☉ Regularny *monitoring* metaboliczny

NICE (2014) i polskie standardy: każdy pacjent na antypsychotyku powinien mieć **regularne badania kontrolne**. Jeśli psychiatra ich nie zleca — pytaj. To Twoje prawo i Twoje zdrowie.

CO 3 MIESIĄCE

- Waga, BMI
- Ciśnienie tętnicze
- Obwód talii
- Subiektywna ocena samopoczucia fizycznego

CO 12 MIESIĘCY

- Glukoza na czczo, HbA1c
- Profil lipidowy (cholesterol, trójglicerydy)
- EKG
- Pełna morfologia, próby wątrobowe

Lekarz rodzinny: mimo opieki psychiatrycznej — utrzymuj kontakt z lekarzem POZ. Wizyta raz w roku, szczepienia, profilaktyka onkologiczna. Diagnostic overshadowing (zob. handout o stygmie) jest realnym problemem — czasem trzeba poprosić o drugą opinię.

RUCH • 150 MIN/TYDZ.

Umiarkowana aktywność: spacer, rower, pływanie. Firth (2015): redukcja objawów negatywnych, poprawa funkcji poznawczych, lepszy nastrój.

DIETA

Mniej cukru, fast food, słodkich napojów. Więcej warzyw, błonnika, białka. Dieta śródziemnomorska — najsilniejsze dane.

RZUCANIE PALENIA

Nikotynowa terapia zastępcza (NRT), wareniklin (Champix), wsparcie psychologiczne. Mit, że „palenie pomaga na psychozę” — nie pomaga.

SEN • 7–9 H

Regularna pora kładzenia się, ciemny pokój, bez ekranów godzinę przed snem. Sedacja od leku nie zastępuje jakościowego snu.

BEZ UŻYWEK

THC, amfetamina, alkohol — nasilają objawy. Kawa do 3 filiżanek dziennie, nie po południu. Energy drinki — unikać.

LEKI METABOLICZNE

Omów z psychiatrą: metformina przy przybieraniu na wadze, zmiana antypsychotyku na lek z mniejszym ryzykiem metabolicznym (np. aripiprazol).

Nie wszystkie sześć obszarów naraz. Wybierz **trzy** z sekcji 3, które są najbardziej realne. Małe, mierzalne, konkretne — i datą startu.

ZMIANA 1

— co, kiedy, jak często

ZMIANA 2**ZMIANA 3**

Klucz: 15–20 lat krótszego życia to *nie* nieuchronność. To **skutek czynników modyfikowalnych**. Firth i in. (2015, meta-analiza 17 RCT z ~385 pacjentami): *ćwiczenia aerobowe 3×/tydz. po 30 min* miały wielkość efektu $d \approx 0,4$ dla objawów negatywnych — porównywalną z najlepszymi interwencjami farmakologicznymi. To jeden z *nielicznych* sposobów, by realnie poprawić objawy negatywne, na które leki słabo działają. Każda wizyta psychiatryczna powinna obejmować **zdrowie fizyczne**, nie tylko psychiczne. Jeśli psychiatra o tym nie pyta — zapytaj sam/-a. Twoje zdrowie fizyczne jest *równie ważne* co psychiczne — a w długiej perspektywie często *ważniejsze*.